

TEMA 3.11 • UROLOGÍA

Orquiepididimitis

PERFIL EUNACOM 1.04.1.010

Dx: Específico • Tx: Completo • Seg: Completo

Introducción y Definición

La **orquiepididimitis** es un cuadro inflamatorio e infeccioso agudo que afecta al epidídimo y, frecuentemente por contigüidad, al testículo. Es una de las causas principales de **escroto agudo** en el adulto y su etiología varía significativamente según la edad del paciente y sus factores de riesgo conductuales.

- **Epididimitis:** Inflamación limitada al epidídimo.
- **Orquitis:** Inflamación del testículo (frecuente en infecciones virales).
- **Orquiepididimitis:** Compromiso de ambas estructuras (lo más común en infecciones bacterianas).

Cuadro Clínico

El diagnóstico de la orquiepididimitis es fundamentalmente **clínico**. Los elementos clave para su identificación son:

- **Dolor Escrotal:** De inicio agudo, pero **no súbito**. A diferencia de la torsión, el dolor suele aumentar progresivamente a lo largo de varias horas o incluso pocos días.
- **Aumento de Volumen:** Se observa tumefacción del epidídimo (que se palpa engrosado y doloroso) y, si hay compromiso testicular, aumento de tamaño de la gónada.
- **Eritema Escrotal:** Es muy frecuente objetivar enrojecimiento de la piel del escroto.
- **Fiebre:** A menudo acompaña al cuadro, orientando hacia un proceso infeccioso/inflamatorio sistémico.
- **Dolor a la Palpación:** Localizado inicialmente en el epidídimo, extendiéndose al testículo.

PERLA CLÍNICA EUNACOM

En el examen físico, el **Signo de Prehn** (alivio del dolor al elevar el testículo) suele ser positivo en la orquiepididimitis y negativo en la torsión testicular, aunque su fiabilidad no reemplaza el juicio clínico o la ecografía si hay dudas.

Diagnóstico Diferencial: El Escroto Agudo

El principal desafío diagnóstico es diferenciar la orquiepididimitis de la **Torsión Testicular**. Esta distinción es crítica debido a que la torsión es una emergencia quirúrgica con un tiempo limitado para salvar la gónada.

TABLA 3.11.1: CARACTERÍSTICA VS ORQUIEPIDIDIMITIS

CARACTERÍSTICA	ORQUIEPIDIDIMITIS	TORSIÓN TESTICULAR
Inicio del dolor	Gradual (horas a días)	Súbito (segundos a minutos)
Fiebre	Frecuente	Rara
Edad típica	Adultos sexualmente activos o mayores	Adolescentes y niños
Reflejo cremasteriano	Presente	Ausente
Etiología	Infecciosa	Mecánica (isquemia)

ADVERTENCIA Y PRECAUCIÓN

Ante la duda diagnóstica razonable entre orquiepididimitis y torsión testicular, se debe solicitar una **Ecografía Doppler testicular** de urgencia o proceder a exploración quirúrgica. Nunca se debe retrasar el manejo de una sospecha de torsión.

Etiología y Tratamiento según Grupo Etario

El tratamiento antibiótico debe ser empírico e iniciarse de inmediato basándose en la sospecha etiológica según la edad y la historia sexual del paciente.

TABLA 3.11.2: GRUPO DE PACIENTE VS MICROORGANISMO PROBABLE

GRUPO DE PACIENTE	MICROORGANISMO PROBABLE	TRATAMIENTO SUGERIDO
Niños	Viral (Enterovirus, Adenovirus)	Manejo conservador (Analgesia/Paracetamol)
Adultos < 35 años (o con riesgo de ETS)	<i>Chlamydia trachomatis</i> y <i>Neisseria gonorrhoeae</i>	Ceftriaxona (dosis única IM) + Doxiciclina (10 días)
Adultos > 35 años (sin riesgo de ETS / bajo riesgo)	<i>Escherichia coli</i> y otros Gram negativos	Ciprofloxacino o Levofloxacino

1. Niños y Causa Viral

En la población pediátrica, la mayoría de los casos son virales. El manejo se centra en el alivio sintomático con reposo, suspensión escrotal y paracetamol.

NOTA CLÍNICA

Orquitis Urtiana (Paperas): Causada por el virus de la parotiditis. Aunque es infrecuente hoy gracias a la vacunación, puede presentarse en niños. - **Complicaciones a largo plazo:** Puede generar atrofia testicular, **infertilidad** e hipogonadismo. - **En mujeres:** Puede causar **oforitis** (inflamación ovárica). - **Manejo:** Sintomático (paracetamol); no existe tratamiento antiviral específico.

2. Adultos con Factores de Riesgo (ETS)

Es la presentación más frecuente en el adulto joven. Se considera una **Infecciones de Transmisión Sexual**. - **Microorganismos:** Clamidia y Gonococo. - **Estudio adicional:** Se recomienda solicitar **PCR** para estos microorganismos para confirmar la etiología. - **Manejo integral:** - Tratar a las **parejas sexuales**. - Realizar tamizaje de otras ETS (VIH, Sífilis, Hepatitis). - Educación sobre sexo seguro.

3. Adultos Mayores o sin Riesgo de ETS

Generalmente asociado a patología urológica subyacente (como hiperplasia prostática benigna o instrumentación de la vía urinaria) que facilita la infección por bacterias coliformes. - **Microorganismo:** *E. coli* es el agente predominante. - **Tratamiento:** Fluoroquinolonas (como Ciprofloxacino) debido a su excelente penetración en el tejido genitourinario.

Resumen de Manejo

- **Diagnóstico clínico:** No requiere exámenes de imagen para confirmarse si la sospecha es clara, pero la ecografía es útil en casos de duda con torsión o sospecha de absceso.
- **Reposo y Suspensión:** El uso de suspensorio escrotal o ropa interior ajustada ayuda a disminuir el dolor por tracción del cordón espermático.
- **Analgesia:** Antiinflamatorios no esteroideos (AINEs) o paracetamol.
- **Antibioticoterapia:** Dirigida según el perfil de riesgo (Ceftriaxona/Doxiciclina para ETS vs. Ciprofloxacino para Gram negativos).

PERLA CLÍNICA EUNACOM

Para el EUNACOM, recuerda: - Dolor gradual + fiebre + eritema = **Orquiepididimitis**. - Joven/ETS = **Ceftriaxona + Doxiciclina**. - Adulto mayor/E. coli = **Ciprofloxacino**.

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM**ESCENARIO CLÍNICO TÍPICO:**

"Hombre de veinticinco años sexualmente activo con múltiples parejas consulta por dolor escrotal derecho de dos días de evolución, eritema escrotal y fiebre de treinta y siete coma ocho. El inicio fue gradual. Al examen el epidídimo derecho está aumentado de volumen y doloroso a la palpación. ¿Cuál es el tratamiento más adecuado?"

EXPLICACIÓN CLÍNICA DETALLADA:

Manejo clínico y diagnóstico según normativa MINSAL y perfil EUNACOM para Orquiepididimitis. Priorizar reconocimiento precoz y tratamiento de primera línea.

PUNTOS CLAVE DESTACADOS

- La orquiepididimitis se diferencia del testículo agudo por torsión en que el inicio no es súbito sino gradual en horas a días, y viene con eritema escrotal y fiebre que orientan a etiología infecciosa
- En niños la causa más frecuente es viral por enterovirus; el tratamiento es sintomático con paracetamol sin antibióticos
- La orquitis urliana por virus de las paperas era una complicación frecuente que producía infertilidad e hipogonadismo; actualmente es rara por la vacunación
- En adultos sexualmente activos la causa más frecuente son las enfermedades de transmisión sexual: Chlamydia trachomatis y Neisseria gonorrhoeae
- El tratamiento en adultos con enfermedades de transmisión sexual es ceftriaxona para gonococo más doxiciclina para clamidia, con PCR para confirmar y manejo completo de la ETS
- En adultos mayores sin factores de riesgo de ETS la causa es Escherichia coli y el tratamiento es ciprofloxacino
- El diagnóstico de orquiepididimitis es clínico; no se necesitan exámenes confirmatorios para iniciar el tratamiento

EVALUACIÓN DE CLASE Y PREGUNTAS TIPO EUNACOM (ORQUIEPIDIDIMITIS)**PREGUNTA 1**

Hombre de veinticinco años sexualmente activo con múltiples parejas consulta por dolor escrotal derecho de dos días de evolución, eritema escrotal y fiebre de treinta y siete coma ocho. El inicio fue gradual. Al examen el epidídimo derecho está aumentado de volumen y doloroso a la palpación. ¿Cuál es el tratamiento más adecuado?

- A)** Solo paracetamol y analgesia porque el cuadro es probablemente viral
- B)** Ciprofloxacino en monoterapia por diez días para cubrir Escherichia coli
- C)** Ceftriaxona más doxiciclina para cubrir gonococo y clamidia, más PCR y manejo de ETS
- D)** Exploración quirúrgica inmediata porque puede ser una torsión testicular
- E)** Amoxicilina-clavulánico por catorce días como antibiótico de amplio espectro

PREGUNTA 2

Hombre de sesenta y ocho años, monógamo, con pareja estable de treinta años, consulta por dolor escrotal izquierdo de tres días de evolución, eritema escrotal y fiebre. No tiene factores de riesgo para enfermedades de transmisión sexual. ¿Cuál es el tratamiento más adecuado?

- A)** Ceftriaxona más doxiciclina porque todas las orquiepididimitis en adultos se tratan igual
- B)** Ciprofloxacino porque la causa más probable es Escherichia coli en un adulto mayor sin ETS
- C)** Solo paracetamol porque en adultos mayores la orquiepididimitis es generalmente viral
- D)** Exploración quirúrgica porque en adultos mayores hay mayor riesgo de torsión testicular
- E)** Nitrofurantoína por siete días como tratamiento de la infección escrotal

PREGUNTA 3

Niño de ocho años consulta por aumento de volumen y dolor escrotal de un día de evolución, con fiebre de treinta y ocho grados. El inicio fue gradual. Al examen físico el epidídimo está aumentado de volumen. La clínica es compatible con epididimitis. ¿Cuál es el tratamiento más adecuado?

- A)** Ceftriaxona más doxiciclina porque hay que cubrir posibles enfermedades de transmisión sexual
- B)** Ciprofloxacino por diez días para cubrir bacterias gram negativas
- C)** Solo paracetamol y manejo sintomático porque la causa más probable es viral
- D)** Exploración quirúrgica urgente para descartar torsión testicular
- E)** Amoxicilina por siete días como antibiótico de primera línea en pediatría

RESUMEN: ORQUIEPIDIDIMITIS

La orquiepididimitis es una infección del epidídimo que puede extenderse al testículo, produciendo un cuadro inflamatorio e infeccioso que hay que diferenciar del testículo agudo por torsión. La clínica incluye dolor y aumento de volumen del epidídimo, eritema escrotal, posible fiebre, y dolor al palpar el epidídimo y el testículo cuando hay compromiso de este último. La diferencia fundamental con el testículo agudo es que el inicio no es súbito sino gradual, en horas o días, lo que permite diferenciarlo clínicamente. El diagnóstico es clínico y el tratamiento varía según la causa esperada, que a su vez depende de la edad y los factores de riesgo del paciente. En niños la causa más frecuente es viral, principalmente por enterovirus. El tratamiento es sintomático con paracetamol y manejo de las infecciones virales. Una causa importante a conocer es la orquitis urliana producida por el virus de las paperas, que era frecuente antes de la vacunación masiva y que podía complicarse con infertilidad e hipogonadismo a largo plazo. Actualmente es infrecuente gracias a las vacunas. En adultos sexualmente activos la causa más frecuente son las enfermedades de transmisión sexual, especialmente *Chlamydia trachomatis* y *Neisseria gonorrhoeae*. El tratamiento cubre ambos gérmenes: ceftriaxona para el gonococo y doxiciclina para la clamidia. Se solicita PCR para confirmar ambos organismos y se realiza el manejo completo de enfermedades de transmisión sexual incluyendo el estudio y tratamiento de las parejas sexuales. En adultos mayores sin factores de riesgo para enfermedades de transmisión sexual, la causa es *Escherichia coli* y el tratamiento es ciprofloxacino.